MEMORIA DA REUNIÃO CIB EXTRAORDINÁRIA

PAUTA: ENCHENTE

DATA 03/03/2024

ONLINE

AS 16H

DR.PEDRO

Dr. Pedro Pascoal – Secretário de Estado de Saúde, na reunião extraordinária da CIB realizada hoje (03/03/2024), informou que a Dra. Ethel Maciel - Secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente estará em Rio Branco amanhã dia 04 de março. E para que ele possa passar todos os dados fidedignos solicitou aos municípios atingidos pelas enchentes que encaminhem em caráter de urgência as informações contidas na Nota Orientativa: Solicitação de Kit VIGIDESASTRES:

- Número total da população atingida/afetada;
- Número de desabrigados, desalojados;
- Número e nome de bairros atingidos/afetados;
- Número e nome das unidades de saúde atingidas (unidades hospitalares e atenção básica), cujo atendimento está prejudicado e se houve eventual perda de medicamentos com alagação;
- Bairros/comunidades atingidos com falta de energia;
- Bairros/comunidades atingidos com falta de sinal de telefonia;
- Descrição de vidas perdidas, afogamentos, acidentes relacionados;
- Estoque atual de medicamentos e insumos para atender a população são suficientes ou não;
- Qualquer informação que seja relacionado a danos causados direta ou indiretamente pela inundação

As informações devem ser encaminhadas para: cib.acre@gmail.com e cosems.acre@gmail.com

Município de JORDÃO – Sec. Oscar

- Não trem plano de contingência;
- Manutenção das unidades, custeio;
- Recuperação das UBS;

Município de Marechal Thaumaturgo-43% da população foi atingida

- Agravos que estão surgindo: Diarreia, febre dor de cabeça;
- Sobre apoio de profissionais técnicos;
- 01 UBS atingida;

DR.PEDRO

- Esclareceu sobre os Decretos e o recebimentos dos Kits VIGIDESASTRE pelos municípios;
- Falou sobre a Força nacional do SUS como um dos componentes de urgência e emergência;

- Falou dos ajustes que cada município deve fazer junto as suas equipes para atender as demandas de assistência;
- Orientou sobre a Portaria GM/MS Nº 3.160 de 09 de Fevereiro de 2024;
- Falou do Apoio da SESACRE aos municípios mais próximos da capital, com equipe de residentes;
- Necessidade de elaboração de Nota técnica sobre os agravos
- Da importância das Notificações compulsória
- Teste rápido de leptospirose
- Medicação para leptospirose

ADRIANA

- Esclareceu sobre a importância da alimentação do levantamento dos abrigos diariamente;

MEMORIA DA REUNIÃO

PAUTA: ENCHENTE/VISITA TÉCNICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA 04/03/2024

AS 8h40min

Apresentação formal da equipe, sala de situação e Ministério da Saúde-VIGIDESASTRE.

LUIZ BELINO PONTO FOCAL MS/VIGIDESASTRE

- Comunicado as áreas temáticas, GT animais peçonhentos do MS, PNI, se houve perda de insumos nas salas de vacinas; vigilância e qualidade da água, insumos para avaliação de qualidade;
- Falou sobre a Portaria de recurso emergencial/Portaria GM/MS Nº 3.160 de 09 de Fevereiro de 2024, isso ajuda na questão dos KITs,
- Hoje à noite chegará ao Acre a profissional Taciana, força nacional do SUS
- Falou da disponibilidade da Equipe da SESAI – Secretaria indígena -Vanderson
- Pontuou a preocupação das chuvas nas regiões de fronteira permaneçam por alguns dias
- Dialogar com a defesa civil para o aporte desses insumos águas e alimentos... etc,
- Pontuou a CGELAB MS/reposição de Material e apoio diagnostico;
- CGEVAM APORTE DE ALGUNS INSUMOS, formalizar a solicitação de insumos, reposição ou de forma complementar
- Precisa ser levantar a Carência de profissionais, médicos, enfermeiros junto aos municípios.
- Abrir diálogo através do COSEMS junto aos municípios;

- Monitorar os municípios pós enchente.

CRISTILENE MS/VIGIDESASTRE

- Trazer a defesa civil, GAD, para as articulações com ajuda humanitária;

ADRIANA

- O Estado já solicitou e já foi enviado ao MS o decreto de emergência em saúde publica

Ana Cristina

- Articulação com a secretaria indígena, o que é pauta social e o que é pauta da saúde; compartilhar as responsabilidades, fazer alinhamento das ações, **alinhamento único;**
- Definir agenda com a secretaria/ povos indígenas;
- Processo de horas voos, situação especial de acesso, questionamentos de valores dos órgão de controle , contratação em relação ao serviço, envolver o MP para auxiliar no processo, definir agenda.
- Copilar as informações das pessoas indígenas;
- Sugeriu que tenha, sala de situação/sala de comando dentro da secretaria indígena;
- Ter protocolos de acesso para atendimento;
- Monitorar os municípios sobre a nota técnica do LACEN /Leptospirose;
- Orientar as equipes sobre o manejo leptospirose;
- Os municípios precisam sinalizar para SESACRE a necessidade de profissionais PARA QUE POSSAMOS ACIONAR A FORÇA NACIONAL.

VANDERSON MS/SESAI

- Ajuda humanitária, entrega de informações será o apoio nesse momento;
- Falou da necessidade de comando único e documento unificado.
- Ferramenta de plano de ação que precisa ser efetivada e que já tem como ação o enfrentamento de situações de emergências em saúde publica paras as pessoas indígenas;
- Equipe DSEI/Purus ficara disponível para apoio a sala de situação;

WANDERSON DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO/SESACRE

- Falou da necessidade humanitária foi específico da SESACRE, população indígena na rua, demais entes precisam ser envolvidos para ajuda humanitária;
- Atendimento na unidade na população indígena, vão tomar agua contaminada.

RELBEN, PONTO FOCAL SALA DE SITUAÇÃO

- Publicizar o informativo diário, falou sobre a reunião da CIB, e demais informações da sala de situação

- Manejo de medicação leptospirose , e estoque e necessidades junto aos municípios

NARA OLIVEIRA REPRESENTANTE DO COSEMS

- Falou sobre os municípios que estão com os decretos de Saúde Pública: **Sena Madureira, Rio Branco, Placido de Castro, Santa Rosa do Purus, Assis , Brasileia ,Epitaciolnadia, Xapuri,Taraucá, Feijó, Marechal Thaumaturgom e Porto Walter** (somente amanhã será publicado)
- Colocou a equipe a disposição.

TAINA/LACEN

- Referência é FIOCRUZ;
- IGM A PARTIR DO 5º DIA ;
- Todas as regionais estão abastecidas de KIT /Leptospirose;
- Compra direta, falou da logística e;
- Nota técnica para os municípios.

DRA. ETHEL MACIEL - SECRETÁRIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE

Passar para a secretaria quais são as principais demandas dos municípios

- Insumos para análise da água;
- Medicação da Leptospirose- área técnica já esta fazendo o levamento junto aos municípios;
-

DRA. ETHEL –

- Concentrar tudo na SESACRE, autoridade sanitária, organizar a resposta e fluxo único para o MS;
- Recurso do PAC, insumos informou que o Estado receberá;
- Laboratório descentralizado;
- Chamar a coordenadora da CGELAB para fazer um diálogo para verificar necessidade de descentralizar;
- Pedidos estruturados e justificados;
- Organizar as demandas dos laboratórios (estrutura , construção e ampliação, equipamentos);
- Custeio e investimento;
- Vigilância -120 mil por mês, a mais do que recebem;
- O MS Passa o recurso, porém a não utilização não utilizar não pode acontecer,

RELBEN PONTO FOCAL SALA DE SITUAÇÃO

Apresentou o informe diário, com todos os detalhes.

Dr. Pedro

- Atendimento assistencial nos municípios mais afetados é uma das demanda mais necessárias;
- LAFRON- Juruá apenas suporte, levantamento de equipamentos e LACEN recurso de PAC;
- Falou da dificuldade da logística da coleta sobre a situação da arbovirose na vinda anteriormente do MS;
- Síndromes febris na Amazonia;
- Manejo das arboviroses, leptospirose.

ADRIANA LOBÃO

Pontual a necessidade dos insumos para **enchentes, pós -enchentes e arboviroses**

EMORIA DA REUNIÃO

PAUTA: SINDROME FEBRIL AGUDA / MUNICIPIO DE PORTO WALTER

DATA 05/03/2024

AS 9h

DIANI CARVALHO -COORDENAÇÃO DA REGIÃO DE SAUDE -JURUÁ TARAUCÁ ENVIRA

Contextualizou o cenário - pacientes da zona rural e da cidade apresenta síndrome febril aguda, sem causa definida, mais de 40 % da zona rural com mesmo sintoma, sendo necessário um plano de ação para o enfrentamento.

ANA FLÁVIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO WALTER

E COORDENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA- DAIANI

- Existência da síndrome febril aguda antes da enchente,
- Aumento com a enchente;
- unidade mista**: em uma manhã 150 receitas** foram atendidas com prescrição de antitérmicos;
- Pacientes procuram o serviço de saúde, porém não fazem o exame de dengue, somente para buscar remédios;
- Não tem estoque de dipirona e nem paracetamol;
- Preciso resolver a situação, resposta imediata com o apoio do Estado;
- Não tem laboratório;
- Não tem medicação.

JAMYLA -COORD.EPIDEMIOLÓGICA DE PORTO WALTER

- Notificação antes de alagação – grande número especificamente um bairro do segundo distrito, amostra envida imediatamente para LAFRON até 36h,

- Apoio do estado para mandar a amostra todos os dias, ressaltou o apoio do estado;
- População tem o costume de se medicar, 02 dias para fazer a sorologia ele não volta mais para fazer a sorologia;
- Dificuldade de mandar a mostra, 02 vezes na semana
- Casos suspeito de dengue, foram notificados;
- Notificação precisa ser feita na Unidade Mista, isso não tem sido feito, e não é por falta de diálogo,
- Os atendimentos de zona rural, estão fazendo uma análise dos prontuários
- Exame específico do Oropouche seria importante nessa situação, emergencial;
- Para fechar a investigação precisa exame sorológico;

MILENA LOPES-CIEVS

- Vigilância fragilidade (baixa notificações, organização da rotina da vigilância)
- Baixa positividade para dengue;
- Buscar a causa da síndrome febril;

ANDREA – NÚCLEO DE DOENÇAS VETORIAL

- Informações oficiais – checar as informações dos sistemas – 37 causas provável de dengue Porto Walter
- A vigilância trabalha com causa suspeita;
- Agravo precisa ser notificado no sistema, com os preenchimentos corretos até que se encerre;
- Doenças de notificação compulsória, precisa ser encerrada no tempo oportuno, do contrário, recurso é suspenso, encerrado até 60 dias;
- notificação precisa ser inserido no sistema para produção da informação como base para as intervenções
- Fluxo e qualificação das notificações, para produção de dados factíveis;
- Teste de Igg não serve para encerrar nenhum caso;
- Exame de biologia molecular identifica, ZDC identifica três agravos
- Falta de kits para realização de exame do Oropouche, não é culpa dos entes
- Kits não vende em larga escala, por conta da importância da arbovirose que não estavam sendo incluída em uma vigilância sistêmica de outros agravos.
- O MS consegui fazer uma compra dos fornecedores que disponibilizam os kits, porém a produção é de baixa escala;
- Para realização dos testes precisam de vários componentes do KIT para realização para fazer a testagem, Entretando o estado não tem todos esses componentes;
- Porto Walter precisa fazer essa coleta conforme nota técnica disponibilizado;
- Fazer análise dos casos no nível local, o município precisa fazer essa analise se é de zona rural, urbana etc.
- Falou do tratamento sintomático, então não precisa aguardar o resultado do exame para iniciar o manejo.

ENCAMINHAMENTOS:

ADRIANA LOBÃO - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

RESPOSTA IMEDIATA:

- Enviar uma equipe composta por área técnica da arbovirose, CIEVS e representante da regional para acompanhamento in loco;
- O município precisa providenciar uma lista de medicamentos e insumos que estão necessitando;
- Verificar junto ao município sobre a necessidade de equipe de assistência (médico e enfermeiro), se sim, providenciar.

RESPOSTA CONTÍNUA

- Entrar em contato com a unidade mista para os esclarecimentos e qualificação das notificações, e articular reunião por regional de saúde com equipe da unidade mista a saber: gerente geral, gerente de assistência e profissional designado para as notificações nas Unidades Mistas.

MEMORIA DE REUNIÃO

DATA:06.03.2024

Pontos abordados

- Deslocamento das equipes para a entrega dos kits VIGEDESASTRE/MS nos seguintes municípios: TARAUACÁ, XAPURI E FEIJÓ SANTA ROSA E PORTO WALTER;
- Atuação da equipe de saúde bucal nos abrigos estaduais com exceção do parque de exposição;
- Departamento Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar reuniu-se para tratar das peculiaridades do Plano de Ação referente a Portaria GM/MS Nº 3.160 de 09 de fevereiro de 2024m a destacar:
- Logística de armazenamento dos hipocloritos; parte do hipoclorito está na antiga escola DOM BOSCO (200 caixas fechadas) e frascos soltos sem embalagem adequadas, equipe técnica já organizou e no deposito 9 mil caixas (cada caixa com 50 frascos) da secretaria municipal de saúde de Rio Branco,
- Chegando 7. 500 caixas;
- Almoxarifado específico para vigilância.

ENCAMINHAMENTOS:

- Qualificação da Produção via boletim de produção ambulatorial individualizado BPAI; **(EMANUELLE, NERTAN, CELENE**)
- Qualificação dos dados de notificação de agravos (**EMANUELLE NOBREGA, NERTAN,GERINÊS)**
- Manejo Clínico da LEPTOSPIROSE;(**JULIA, CELENE)**
- EQUIPE TI, Ira atualizar o painel RENAVEH E PAINEL DA DENGUE (**TI)**
- Providenciar um espaço, um almoxarifado específico para vigilância para insumos e hipoclorito (**JAMAYLA E WANDERSON**)

BRUNO MEIRELES - DSEI ARP-

Pontos compartilhados para conhecimento da sala de situação

- Momento crítico indígenas atingidos 4.477 (dados de hoje);
- Medicamentos e insumos;
- Equipe em Assis Brasil, Santa Rosa Manoel Urbano;
- Três equipes em área;
- Foi feito a entrega dos filtros e cestas básicas para os indígenas;
- Situação crítica com a baixa da água;
- Maior preocupação e alimentação pois os roçados foram destruídos;
- Existe também uma sala de situação;
- Maior dificuldade com as entregas, acesso (cestas básicas e atendimento)
- Secretaria Estadual dos Povos Indígenas– disponibilizam cesta básica e kits bde limpeza;
- DSEI- Disponibilizam filtro de barro e hipoclorito;
- Comitê de eventos extremos, já tem plano elaborado para publicação do Decreto.

MARCICLEIDE – DSEI ARJ/CIEVS

Pontos compartilhados para conhecimento da sala de situação

- 91 aldeias atingidas 7. 150mil (de ontem)
- SEP- Secretaria Estadual dos Povos Indígena – disponibilizam cesta básica e kit de limpeza
- DSEI- Disponibilizam filtro de barro e hipoclorito;
- Fluxo de entrega esta descentralizado para FANAI (disponibilizam cesta básica e kit de limpeza, filtro de barro e hipoclorito)
- Desmobilização dos abrigos em Marechal Thaumaturgo;
- Manutenção da assistência em todo território;

- Notificações e informações epidemiológicas, por conta dos dias de folga da equipe, e também não tem internet em área, não tem a informação em tempo real

GARRAFIEL TI - OBSERVATÓRIO EM SAÚDE

OBSERVATÓRIO - SESACRE – composto pelo os **painéis** (quando a área quer dar transparência ao seu trabalho) **indicadores** (não tem, equipe precisa solicitar a inserção no observatório) e **boletins** (chefe da área).

ENCAMINHAMENTO

- Aprimorar o fluxo de gestão da alimentação do observatório, com cronograma de execução de tarefas junto com os departamentos prioritários e TI .

NERTAN/NOTIFICAÇÕES

- 17 notificações em 214 exames no Estado;
- Dificuldade de internet e de utilização da ficha
- Pode fazer manual e encaminhar para LACEN processar;
- Sistema GAL
- Falha da informação inserida no sistema;

ENCAMINHAMENTOS:

- Nota circular com base no decreto de emergência em saúde pública e Portaria nº 3.160 para intensificar as notificações com o apoio do COSEMS bem com levar a discussão na CIR (VIGILANCIA/VE E VA)

MEMORIA DE REUNIÃO

Dia:07 de março de 2024

Horário:8h

Local: SESACRE 4º Andar, lado B

Ponto focal da Sala de situação: Relben

PAUTA: LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES LACEN PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO REFERENTE A ENCHENTE.

PONTOS LEVANTADOS - JAMAYLA E WANDERSON TAINA

- Levantamento do recurso para o transporte aéreo para os 180 dias ;
- Fortalecimento dos laboratórios inclusive LAFRON Cruzeiro do Sul com o Levantamento das necessidades, insumo e estrutura a destacar as solicitações que já estão em andamento no **SEI-9937005 DVS;**
- Fazer um emergencial para contrato de equipamentos (Suprir todas as unidades);
- Articular a ida da equipe, planejamento e do LACEN para verificar a questão do hospital de campanha como alternativa;
- Faz-se necessário separar as necessidades que são de custeio, pois as de investimento ficaria para segundo momento;
- Análise microbiológica, o problema é chegar no LACEN as amostras, dos 22 municípios somente 07 municípios entregam a amostra no LACEN, pois relatam não disponibilizarem de material adequada para coleta (saco estéril);
- Relatou-se a necessidade da Vigilância ter uma central de demanda , e um almoxarifado específico;

ENCAMINHAMENTOS:

- Garantir a ida da equipe, planejamento e LACEN para verificar a questão do hospital de campanha de cruzeiro para ocupação do LAFRON (JAMAYLA);
- Fazer o Levamento de todas as necessidades do DARF e LACEN e MMH (TAINA e SUELLEM); **PRAZO PARA ENTREGAS DAS RESPOSTAS – ATÉ DIA 15/03/2024;**
- Fazer o levantamento do recurso para o transporte aéreo dos 180 dias (WANDERSON)
- Levar para a reunião dos diretores e secretários, a necessidade da criação de uma central de demanda da DVS, e de ter um almoxarifado específico;

PAUTA: NECESSIDADES APONTADAS PELAS AREAS TÉCNICAS

HORA:10H

- Dom Bosco lugar de armazenamento de Hipoclorito está apresentando goteiras, apresentou-se a preocupação com o acondicionamento pois o recebimento é de de 6.470 caixas mês;
- Entrar com a manutenção IMEDIATA no Dom Bosco ou levar para o prédio do parque ou outro espaço que seja adequado para o acondicionamento
- Parecer Técnico do MS referente a reposta negativa de solicitação de mais Kits DESATRE – medicamentos e insumos estratégicos , para os municípios de Sena Madureira, Brasileia e porto Acre, por não informar o número de unidades de saúde que tiveram perda de medicamentos e insumos;

- Doxiciclina – distribuição para os municípios será verificado junto ao DARF por conta da data de vencimento, foi disponibilizado pelo DARF 8mil comprimidos;
- Ação saúde bucal – feito um diagnostico escola Ilka Maria;
- Atualizar o informe diário, especialmente dos dados demográficos, será mantido fonte somente do CIEVS;
- Nota técnica junto com o LACEN sobre as notificações das arboviroses;
- Painel RENAVE não está sendo alimentado - alimentação diárias dentro das Unidades de Âmbito estadual (Unidades Mistas, UPAS e Hospitais); quanto a leptospirose é necessário manejo clinico dos médicos, e não esperar resultado de exame, para condutas;
- Pós enchente - A qualificação da leptospirose ficou acordado junto a equipe do município de Rio Branco (Rafaela e Silvia) a realização nas próprias URPAS pela médica Erenilce, juntamente com Julia da área técnica da leptospirose que fará a articulação com a coordenadora geral da APS do município de Rio Branco.

SALA DE SITUAÇÃO

MEMORIA DE REUNIÃO

Dia:07 de março de 2024

Horário:14h

Local: SESACRE 4º Andar, lado B

Ponto focal da Sala de situação: Relben

Pontos levantados – RELBEN

- Contextualizou sobre a Portaria Nº 3.242, de 04 de março de 2024;
- Falou sobre a doxiciclina e distribuição aos municípios e qualificação dos profissionais;
- Nota técnica e notificações da leptospirose;
- Distribuição de hipoclorito.

Pontos levantados -LUIZ BELINO/ TARCIANA/ MARCOS VINICUIS

- O repasse do recurso deve ser orientado de acordo com o Decreto do Estado de emergência em saúde pública;
- Desdobramento do desastre e quais são as ações (Plano) nos primeiros 15 dias e demais 30 dias, e 45 dias, reavaliar entre 30 e 45 dias;
- Houve uma reunião com a equipe técnica da Leptospirose do MS, se colocou à disposição para fazer uma reunião com equipe do Acre para sanar as dúvidas;
- Sala de situação conversar com a defesa civil para orientação quanto a utilização do hipoclorito para limpar e purificação a agua para consumo humano para não

estarem utilizando para limpezas em geral, pois para este fim é distribuído o kit limpeza;

- Foi apresentado um Guia de Rio Grande do Sul- sobre a orientação da atuação da atenção primária em situação de desastre- adaptar para o acre, destacou a importância dos cuidados psicológico nesse cenário de enchente;
- Destacou-se o possível impacto de médio e longo prazo, mudanças especialmente na saúde mental, impacto referente a desocupação gera sofrimento mental, a exemplo do cenário do município de Brasileia e Jordão, e a importância de revisitar os equipamentos de saúde desses dois territórios,
- **Plano de adaptação do setor saúde**, é preciso estruturar toda a rede Rede de Assistência à Saúde;
- Plano de urbanização;
- Autoridade sanitária de emergência é o COE, através do secretário de saúde é possível acionar os outras entidades;
- CASA de passagem no momento da visita estava sem uma referência técnica em Porto Walter;
- Reunião as 14h – segunda feira -manejo terapêutico arbovirose;
- Plano de Ação COE- apresentado da arbovirose e que será adaptado para enchente, destacar os agravos doenças transmissíveis leptospirose, DDA, acidente animais peçonhentos , acidente de trabalho , saúde mental, acidente com perfuro cortante e traumas.
- **Porto Walter – que dia que entregue a obra da Unidade de âmbito estadual??**
- Modelo de Plano ação- equipe do ministério irá enviar para direcionar a elaboração do plano do estado do acre;
- Produzir informações para os municípios no curso do cenário de enchente, no pós enchente , médio e longo prazo (plano de ação, guia, nota técnica, pós enchente)
- O estado precisa dizer como os municípios vão se comportar diante desse cenário;
- Pactuar na CIB – Plano de ação do COE;
- É necessário falar de saúde mental, não precisa de equipe especializada como psicólogo ou psiquiatra, é preciso ter profissionais qualificados (médico, enfermeiro, técnico entre outros) para entrar nos territórios, Tarciana ficou de enviar o link, sobre os primeiros cuidados psicológico no território atingido pelas enchentes;
- Porto Walter, sobre a síndrome febril, os sintomas não se agravam mais a causa é desconhecida, é preciso testar para **MAYRO E OROPOUCHE**.
- Falta insumos para realizar os testes de **MAYRO E OROPOUCHE.**
- Amostra de porto Walter, Lista do **LAFRON** do Juruá
- Necessário um Protocolo clínico para atendimento aos pacientes com síndrome Febril de Porto Walter;
- Nas unidades do município foi receitado cerca de 3.500 comprimidos de dipirona

SALA DE SITUAÇÃO

MEMORIA DE REUNIÃO

Dia:11 de março de 2024

Horário:13h

Local: SESACRE 4º Andar, lado B

Ponto focal da Sala de situação: Relben

MARCOS VINICIUS

VISITA TÉCNICA AO MUNICIPIO DE PORTO ACRE

- Houve reunião com secretaria Edna, e equipe e todas as atividades que estavam realizando, sem unidade atingida, dois abrigos dentro do município, ficou de passar demanda de equipamentos e medicamentos além do kit, solicitou uma equipe volante;
- Guia da APS está em andamento, é preciso que as áreas da vigilância possam dar uma olhada, naquilo que for preciso inserir (**Marcos ficou de verificar quais áreas precisa inserir as informações);**

JORDÃO

- Seis casos de leptospirose; a unidade de âmbito estadual notifica e o município insere no sistema.

KITs – LUIZ BELINO

CRITÉRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE KITS, A DESTACAR:

- Danos ao estabelecimento de saúde que gere perda de insumos;

- Quantidade de população desabrigadas;

- Soma total dos kits enviados ao estado já atende a demanda da população, readequação da dispensação dos kits, o estado tem total autonomia, e como não houve mudança da população atingida por isso justifica-se o indeferimento aos kits;
- Cruzeiro do Sul apresenta excelente organização de fluxos, isso justifica-se o indeferimento, destacou que os Kits não se aplica a reposição de medicamento, para atender a escassez de medicamentos existe a portaria de financiamento.

Dentro dos critérios existe as necessidades de informações dos **DESALOJADAS** e **DESABRIGADAS**. Atualização da nota técnica sobre os kits, pode subsidiar a sala de situação, evitar os ruídos com os municípios, destacou-se sobre os critérios dos Kits para compartilhar junto ao COSEMS;

GT ROEDORES

- JULIA – falou sobre o guia, realizou contato com as vigilâncias dos municípios, criaram um drive com informações e capacitação sobre leptospirose junto as URAPS, e será também realizado nas UPAS, será disponibilizado um cronograma
- Seis casos suspeitos no Jordão, entre 14 e 40 anos, estes já iniciaram o tratamento;
- Foi feito a nota técnica e visita as unidades sobre a prevenção da leptospirose;
- Falta de medicação- Amoxicilina e doxicicliclina;
- Dispensação aos municípios? Disponibilizado pelo DARF 4mil, com base na série histórica e população do município;
- Lidsy MS/Leptospirose – compra emergencial junto ao DARF;
- Protocolo de leptospirose – inicial Amoxicilina e doxicicliclina;
- A estratégia é tratar todos os suspeitos, não deixar os pacientes agravarem;
- A questão laboratorial refere-se a vigilância epidemiológica, não vai ajudar no momento de crise, o tratamento é clínico;
- O MS enviou nota que faz diferença entre **dengue e leptospirose;**
- Solicitar via e-mail ao MS/Luiz Belino - sobre a questão do baixo estoque de medicação para leptospirose – enviar a solicitação ao **VIGIDESASTRE**, copiar o GT roedores;
- Modelo de plano de ação/PORTARIA Nº 3.160- Luiz Belino irá enviar;

SALA DE SITUAÇÃO

MEMORIA DE REUNIÃO

Dia:12 de março de 2024

Horário:13h

Local: SESACRE 4º Andar, lado B

Ponto focal da Sala de situação: Relben

ENCAMINHAMENTOS:

- Sobre solicitação de medicação do município de Porto Acre, será enviado o e-mail ao DARF com a solicitação do município, para apreciação e encaminhamentos necessários do departamento, considerando que o município já recebeu o KIT VIDESASTRE (MARCOS_
- **PLANO DE AÇÃO DE RESPOSTA A EVENTOS EXTREMOS** (enchentes e arboviroses) (MARCOS)

- COE/Eventos extremos- faz-se necessário a indicação de titular e suplentes para composição do mesmo- (RELBEN e ADRIANA)
- Agendado para amanhã 13/03 às 8h30 - reunião com LACEN/LAFRON Juruá para tratar do fluxo laboratorial do município de Jordão, a destacar exames de leptospirose e arvobivores e respectivas notificações;